

Fecha Última Actualización: 05-01-2026 12:11:02

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Mercedes Del Carmen Martinez Ojeda
Edad : 62a 4m 28d
Dirección : Rio Puelche 3658 Mamiñ A li 0

Rut : 9.679.383-9
Fecha Nacto: 08/08/1963
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0402859
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 7773 0969

N° Epicrisis
467624

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 28/12/2025 16:19

Días Estadía : 8

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 05/01/2026 12:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Mercedes Del Carmen Martinez Ojeda
62 años
Rut: 9.679.383-9
Fecha Ingreso HSR:28/12/25

Antecedentes:

Medicos: asma, artrosis, HTA, DM2IR. insuficiencia cardiaca, cancer de utero operado hace 5 años. Trastorno bipolar.

Qx: histerectomía, colecistectomía.

Fármacos: quetiapina, pregabalina, inuslina NPH, losartan, atv, furosemida, escitalopram

Alergias: (-)

Habitos: TBQ (+)

Paciente con antecedentes descritos, traída por familiares, refieren que a las 3 am la encuentran tomando pastillas, luego se va a dormir. La encuentran a las 12 del día sin respuesta a estímulos, con blíster vacíos de quetiapina 100 mg, estiman ingesta de 50 comprimidos. Sin vómitos, pérdida de control de esfínter ni movimientos tónico clónicos. Sin episodios previos.

Al ingreso a urgencia se describe

a: no emite lenguaje, roncando, sin secreción ni cuerpo extraño en va, sin signos de trauma

b: Sat 85% amb, fr 15, ventila simétrico, sin cianosis

c: PAM 66, fc 110, llene cap 2 seg, tibia, sin livideces, ecg destaca Qt largo

d: Pupilas mióticas, no emite lenguaje, retira a estímulo doloroso, hgt 110

e: sin lesiones en piel

Por compromiso de conciencia se decide protección de vía aérea. Se realiza intubación bajo SRI con TOT#8.0 a 22 cms de AD. Evoluciona con tendencia a la hipotensión, se instala cvc YAD e inicia noradrenalina + vasopresina. Se solicita TAC de cerebro y torax. Se traslada a UCI para continuar manejo.

Diagnosticos de ingreso:

1.- Compromiso de conciencia secundario a ingesta medicamentosa

- Intoxicación por quetiapina

Fecha Epicrisis : 05/01/2026 12:11

Página 1 de 3

- ¿Intento autolítico?
2.- Antecedentes

Evolución en UCI

HDN: a su ingreso con doble vasoactivo. Se volemita con cristaloides con respuesta parcial. No presenta alteración del Qt ni arritmias. Evoluciona con mejoría hemodinámica progresiva, logrando suspensión de vasoactivos, con buena perfusión clínica y lactato en rango. Posteriormente con tendencia a la hipertensión por lo que se inicia terapia vasodilatadora oral. Sin requerimientos transfusionales.

Respiratorio: intubada para protección de vía aérea por compromiso del sensorio, evoluciona con adecuado intercambio gaseoso y mecánica ventilatoria. TAC de tórax con foco de condensación en base izquierda. Evoluciona con lento despertar, tranquila, pasando a modos menos ventilatorios menos asistidos. Se logra extubar el 31/12 saliendo a naricera, consolidando weaning.

Infeccioso: por sospecha de aspiración se inicia terapia empírica con ampicilina/sulbactam, completando 7 días de terapia, con buena respuesta clínica y de laboratorio. Sin nuevas intercurrentes infecciosas.

Renal: no presenta falla renal ni alteraciones electrolíticas durante estadía en UCI.

Psiquiátrico: evaluada por psiquiatría el 02/01/26 se concluye sin ideación suicida activa, con arrepentimiento del intento, sin sintomatología anímica ni ansiosa. Presenta signos de liberación frontal y conductas impulsivas de inicio en la adultez, que hacen sospechar de un eventual trastorno neurocognitivo. Se refiere paciente sin indicación de hospitalización en corta estadía. Al alta se sugiere realizar IC para continuar controles en CRS Cordillera con Psiquiatría dado antecedente de trastorno afectivo bipolar, con indicación de seguimiento por especialidad.

Dado evolución global favorable se solicita traslado a sala de medicina para continuar manejo pero sin disponibilidad de cama básica. Se coordina con familia factibilidad de cuidadores y vigilancia las 24/7 y se programa alta para el 04/12/26.

Diagnósticos de egreso

Síndrome suicidal, intento de suicidio mediante ingesta farmacológica resuelta, sin ideación suicida activa

Antecedente de Trastorno afectivo bipolar

Compromiso de conciencia secundario a ingesta medicamentosa resuelto

Neumonía aspirativa tratada

Diagnóstico de Egreso

TRAST. MENTAL Y DE COMPORTAM. DEBIDO A INTOXICACIÓN AGUDA POR USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS -
Ingesta medicamentosa

Condición de Egreso

Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, en GCS 15, sin ideación suicida ni pensamientos intrusivos, tranquila y cooperadora

Plan Post Alta

- Mantener supervisión 24/7 por familiares hasta control ambulatorio de salud mental.
- Mantener abstinencia de alcohol y otras drogas.
- En caso de angustia inmanejable, agitación, riesgo de auto o hetero daño se sugiere acudir al Servicio de Urgencias.
- Mantener escitalopram 10 mg en la mañana.
- Mantener melatonina 6 mg en la noche, se podría aumentar hasta 9 mg en caso de ser necesario.
- No reiniciar quetiapina.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos : Pregabalina 75 Mg 1 Comprimido Al Día Vo
Omeprazol 20mg 1 Comprimido Al Día Vo
Melatonina 3 Mg 2 Comprimidos En La Noche
Losartan 50mg Cmp 1 Comprimido Cada 12 Horas Vo
Insulina Nph 14 U Am Y 8 U Pm
Hidroclorotiazida 50mg 1 Comprimido Al Día Vo

Fecha Epicrisis : 05/01/2026 12:11



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 05-01-2026 12:11:02

Página 3 de 3

Escitalopram 10 Mg 1 Comprimido Al Dia Vo

Amlodipino 10 Mg 1 Comprimido Al Dia Vo

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Carlos Andrés Pinzon
Médico Tratante (Staff)